

Nevus

Bibliográfica 2019 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David
Asociación Española de Pediatría

El nevus melanocítico es una proliferación anormal pero benigna de los melanocitos de la piel que tienden a agruparse en nidos o tecas.

El 1% de los neonatos (nevus melanocíticos congénitos), el resto suelen iniciar su aparición a partir de los 6-12 meses e ir aumentando en número y tamaño hasta alrededor de los 25 años.

Nevus melanocíticos congénitos

Proliferaciones de melanocitos que se encuentran presentes al nacer o los que aparecen durante los primeros meses de vida y alcanzan con posterioridad un tamaño superior a 1.5 cm de diámetro.

Estos nevus tienen mayor potencial de transformación a melanoma, siendo la proporción directamente proporcional a su tamaño. El riesgo de desarrollar un melanoma durante los primeros quince años de vida son entre el 5% y el 12% y con mayor frecuencia tiene lugar durante los primeros meses-años de la vida.

Los nevus gigantes del área de la cabeza y cuello pueden asociarse a afectación neurológica por infiltración leptomeníngea y de otras estructuras del sistema nervioso central, con aparición de hidrocefalia, retraso mental y melanomas en esta localización (malanosis neurocutánea).

En los que afectan la zona dorsal media puede existir espina bífida y otras anomalías vertebrales y medulares.

Los NMG de las extremidades pueden asociarse a malformaciones óseas.

Nevus melanocíticos adquiridos

Proliferación de melanocitos que se inicia la edad infantil en la unión dermoepidérmica, la mayoría de NM presentes en estas edades son de **tipo juntural**. Con el paso del tiempo, los nidos de melanocitos migran hacia la dermis papilar, dando lugar a los **nevus melanocíticos compuestos**. Posteriormente, el componente juntural disminuye y sólo quedan los melanocitos dérmicos, dando lugar al **NM intradérmico**. El estadio final de un NM es un apéndice cutáneo del color de la piel normal en el que se aprecian muy pocas células névicas, escaso pigmento y algunos adipocitos.

Desde el punto de vista clínico, los nevus junturales son pequeños (1 mm a 1 cm), redondos o elípticos y planos o mínimamente elevados. Su color puede variar desde marrón claro al negro.

Los nevus compuestos son pápulas redondas de color marrón menos intenso. Los nevus intradérmicos son pápulas hemisféricas de superficie lisa o papilomatosa, de tacto duro, a veces blando, pero elástico y poco o nada pigmentadas.

Relación entre nevus melanocítico adquirido y melanoma

La probabilidad de transformación maligna de algún NM adquirido se estima en 1/100.000, por lo que no se justifica la exéresis sistemática de los NM adquiridos. Por otra parte, la presencia de múltiples NM parece que incrementa el riesgo de padecer un melanoma.

Nevus melanocíticos atípicos

Los NM atípicos son, para algunos autores, lesiones intermedias tanto clínica como histológicamente entre los NM y la fase de crecimiento radial de un melanoma maligno.

Los NM atípicos pueden ser un predictor independiente del riesgo de melanoma.

Existen dos tipos de NM atípicos, los esporádicos y los que aparecen en el contexto del síndrome del nevo displásico familiar.

Los NM atípico pueden ser únicos o múltiples, esporádicos y familiares, y se localizan fundamentalmente en el tronco y en los brazos, aunque pueden aparecer en cualquier otra localización. Clínicamente es definido por una morfología asimétrica, la variedad de color con áreas marrón claro y oscuro, incluso áreas despigmentadas, los bordes irregulares y angulosos, y un tamaño entre 5 y 10 mm, aunque pueden ser mayores. Estas características son prácticamente las mismas que se utilizan para describir un melanoma (asimetría, bordes irregulares, color no homogéneo y diámetro superior a 6 mm), por lo cual, en general, estos pacientes son derivados para ser evaluados por el especialista.

Cuando hay dudas se realiza un seguimiento de la evolución temporal, los NM atípicos son lesiones que permanecen estables y no cambian de color ni de forma, ni aumentan de tamaño de forma rápida con el tiempo, los melanomas sí cambian de tamaño, morfología y color de forma apreciable en pocos meses..

Síndrome del nevus displásico familiar

Tienen una transmisión autosómica dominante, de penetrancia y expresividad variable. En estos casos, los NM atípicos suelen desarrollarse durante la infancia, su número ronda las cien lesiones y se distribuyen fundamentalmente por el tronco. El riesgo de desarrollar un melanoma a lo largo de la vida en los pacientes afectos se acerca al 100%, con una probabilidad de hacerlo del 56% entre los 20 y lo 59 años.

Variantes del nevus melanocítico:

- **Nevus de Spitz**

Se trata de una lesión totalmente benigna que puede confundirse histológicamente con un melanoma. Las lesiones son nódulos rojizos, que pueden sangrar con facilidad y alcanzan hasta 1-2 cm de diámetro. La mayoría de ellos aparecen en niños y adolescentes y la localización más habitual es en la cara.

- **Nevus azul**

Se presenta en forma de pápula hemisférica bien delimitada, de superficie lisa y brillante y color entre gris-azulado y azul-negro. Esta coloración es debida a la presencia de melanocitos en la dermis media y profunda. Alrededor de la mitad de los nevus azules se localizan en el dorso de las manos y de los pies, las muñecas y los glúteos.

- **Nevus de Sutton o halo nevus**

Consiste en la aparición en uno o varios NM de un haloacrómico a su alrededor que, en ocasiones, conduce a la hipocromía del nevo e incluso a su desaparición. Este fenómeno ocurre con mayor frecuencia en niños y adolescentes y, sobre todo, en la espalda. Traduce un fenómeno de autoinmunidad contra las células del nevus. Este proceso dura de uno a dos años y la mácula acrómica tiende a pigmentarse de nuevo con el tiempo.

Indicación de tratamiento quirúrgico de los nevus

- Historia familiar de melanoma o de nevus displásico
- Localización en zonas de difícil autocontrol
- Localización en zonas sometidas a irritación continuada
- Localizaciones especiales
 - Mucosa oral y genital
 - Partes acras
 - Matriz y lecho ungueal
- Pacientes de fenotipo I-II sometidos a exposición solar habitual u otras fuentes de radiación ultravioleta
- Características clínicas de la lesión que sugieran malignidad/atipia clínica
 - Asimetría
 - Borde irregular
 - Color heterogéneo
 - Tamaño superior a 6 mm
- Evolución atípica
 - Aparición de sintomatología asociada (prurito, dolor)
 - Aumento rápido de tamaño
 - Cambio en su superficie
 - Sangrado espontáneo

Actitud ante los nevus melanocíticos congénitos

El potencial de malignización de los NMC es fuente de polémica.

La decisión debe ser tomando como los siguientes factores:

El riesgo de malignización

Los riesgos derivados de la intervención quirúrgica y de la anestesia

Los resultados funcionales y estéticos

Los aspectos económicos.

En general, se extirparán los NMC, pero nunca antes de los seis meses de vida.

Cuando la actitud sea conservadora se realiza vigilancia periódica por parte del médico, autovigilancia por parte de los padres y más adelante por parte del propio paciente.